Autos: 0800269-75.2020.8.12.0040
Ação: Procedimento Comum Cível - Fornecimento de medicamentos
Autor:Juliana Paniagua
Réu: Município de Porto Murtinho e outro

Vistos, para sentença.

I. Relatório.

Juliana Paniagua ajuizou a presente "ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência" em desfavor de **Município de Porto Murtinho e Estado de Mato Grosso do Sul**, todos devidamente qualificados nos autos.

Consta na petição inicial que a parte autora encontra-se com 53 anos de idade e foi diagnosticada com transtornos da densidade e da estrutura ósseas (CID10: M85), transtornos de discos intervertebrais (CID10: M51) e transtornos internos dos joelhos (CID10: M23).

Para o tratamento, a(o) médica(o) especialista(o) receitou a(s) medicação(ões) Glucosamina 1,5g+Condroitina1,2g+Magnésio, Naproxeno 250mg, Miosan Caf e Polovitamínico A-. Os fármacos encontra-se registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA.

Postulou pela concessão de tutela provisória de natureza antecipada para obrigar a parte ré fornecer os medicamentos, conforme receita médica, deferido às fls. 41-44.

No mérito, requereu a procedência do pedido para determinar que a parte ré forneça os medicamentos na forma constante da prescrição médica e os necessários no decorrer do tratamento, além da garantia de restituição dos valores eventualmente pagos par aquisição a partir da negativa extrajudicial.

Fez os pedidos de estilo e juntou documentos (fls. 13-24).

Parecer do NAT foi contrário ao pedido (fls. 41-44).

Citada, a parte ré apresentou resposta na forma de contestação (fls. 57-76 e 113-121), arguindo, preliminarmente, a necessidade de inclusão da União no polo passivo com o deslocamento de competência à justiça federal.

No mérito, ressaltou a obrigação de fornecimento de medicação pelo ente público somente pode ser determinada se comprovada a presença cumulativa das condicionantes fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial nº 1.657.156/RJ (Tema repetitivo nº 106).

Afirmou que a parte autora não preencheu os requisitos porque não houve o esgotamento do tratamento disponível, além de não haver fundamentação sobre a ineficácia dos demais fármacos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde.

Requereu a improcedência dos pedidos e, subsidiariamente, no caso de procedência: a) a apresentação obrigatória da receita médica atualizada para retirada do medicamento e autorizado o fornecimento com base no princípio ativo; b) não condenação do Estado no pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública; c) o direcionamento da obrigação à União e, no caso de execução forçada contra a parte

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VINICIUS DOS ANJOS BORBA, liberado nos autos em 27/01/2023 às 17:36 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800269-75.2020.8.12.0040 e código S7R5507E.

ré, a garantia do direito ao ressarcimento; d) que não seja fixada multa diária se determinada a execução forçada da obrigação; e) seja observado o PMVG se houver bloqueio de valores.

No mais, formulou os pedidos de estilo.

Houve impugnação (fls. 161-171).

É o relatório.

Decido.

II. Fundamentação.

a) Da preliminar de incompetência da justiça estadual.

O Superior Tribunal de Justiça, em decisão prolatada no Incidente de Assunção de Competência nº 14, determinou que a Justiça Estadual se abstenha de proferir decisões declinação de competência em ações que envolvem fornecimento de medicamentos pelo poder público[1].

Tendo isso em vista e também a decisão do Supremo Tribunal Federal que reconheceu a repercussão geral no RE 1.366.243 (Tema 1.234), rejeito a preliminar.

b) Do mérito.

O feito está em ordem. Não há preliminares pendentes ou nulidades a sanar.

O processo comporta o julgamento antecipado do mérito, na forma do art. 355, I, do Código de Processo Civil, eis que não vislumbro a necessidade de produção de outras provas em audiência, estando suficientemente instruído para solução da causa.

A parte autora pretende a condenação do Município de Porto Murtinho e Estado de Mato Grosso do Sul no fornecimento do(s) medicamento(s) Glucosamina 1,5g+Condroitina1,2g+Magnésio, Naproxeno 250mg, Miosan Caf e Polovitamínico A- para o tratamento de transtornos da densidade e da estrutura ósseas (CID10: M85), transtornos de discos intervertebrais (CID10: M51) e transtornos internos dos joelhos (CID10: M23).

Inicialmente, aponto que a Constituição Federal de 1988 erigiu o direito à saúde ao patamar de direito fundamental, estabelecendo em seu art. 196 ser um direito a todos, garantido pelo Estado, ao qual compete o desenvolvimento de políticas que visem à promoção da saúde, redução do risco de doenças e, caso esta já se tenha consolidado, ao acesso universal e igualitário a ações e serviços para proteção e recuperação da saúde.

A judicialização das políticas públicas de saúde vem atingindo números elevados de ações e de custos, especialmente em função da prescrição de medicamentos não fornecidos pelo sistema. O SUS, através de seus integrantes, a União, os Estados, Distrito Federal e Municípios, é compelido à prestação de serviços de saúde, sob os princípios da universalidade e integralidade.

O art. 2º e parágrafo 1º da Lei nº 8.080/90 dispõe o seguinte:

> Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

[1] Em sessão realizada em 8/6/2022, A Primeira Seção, por unanimidade, deliberou que, até o julgamento definitivo do incidente de assunção de competência (IAC), o Juiz estadual deverá abster-se de praticar qualquer ato judicial de declinação de competência nas ações que versem sobre tema idêntico ao destes autos, de modo que o processo deve prosseguir na jurisdição estadual, nos termos da questão de ordem proposta pelo Sr. Ministro Relator.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VINICIUS DOS ANJOS BORBA, liberado nos autos em 27/01/2023 às 17:36 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800269-75.2020.8.12.0040 e código S7R5507E.

> § 1º O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

Em relação à obrigação do Estado de fornecer medicamento "off label", o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema Repetitivo nº 106, fixou tese no sentido de que "A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (I) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;(II) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e (III) existência de registro na ANVISA do medicamento."

> Inicialmente cumpre ressaltar que a questão de fornecimento de medicamentos já possui ampla jurisprudência nesta Corte Superior de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que tem entendido que o inciso I do art. 19-M da Lei n. 8.080/1991, incluído pela Lei n.12.401/2011, permite que seja deferido o fornecimento de medicamento não incorporado em atos normativos do SUS. Dos julgados existentes é possível extrair alguns requisitos necessários para que o pleito seja deferido. O primeiro requisito consiste na demonstração da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento no tratamento, por meio de laudo médico circunstanciado e fundamentado, devidamente expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS. Quanto à questão, consta das Jornadas de Direito da Saúde, realizadas pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ, algumas diretrizes sobre a comprovação da imprescindibilidade do medicamento, sendo que no enunciado n. 15 da I Jornada de Direito da Saúde asseverou-se que o laudo médico deve conter, pelo menos, as seguintes informações: "o medicamento indicado, contendo a sua Denominação Comum Brasileira (DCB) ou, na sua falta, a Denominação Comum Internacional (DCI); o seu princípio ativo, seguido, quando pertinente,do nome de referência da substância; posologia; modo de administração; e período de tempo do tratamento; e, em caso de prescrição diversa daquela expressamente informada por seu fabricante, a justificativa técnica". O segundo requisito consiste na devida comprovação da hipossuficiência daquele que requer o medicamento, ou seja, que a sua aquisição implique o comprometimento da sua própria subsistência e/ou de seu grupo familiar. Não se exige, pois, comprovação de pobreza ou miserabilidade, mas, tão somente,a demonstração da incapacidade de arcar com os custos referentes à aquisição do medicamento prescrito. Por fim, o terceiro requisito a ser considerado é que o medicamento pretendido já tenha sido aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA.Esta exigência decorre de imposição legal, tendo em vista o artigo 19-T, inciso II, da Lei n. 8.080/1991, o qual dispõe que são vedados, em todas as esferas de gestão do SUS a dispensação, o pagamento, o ressarcimento ou o reembolso de medicamento e produto, nacional ou importado, sem registro na Anvisa. REsp 1.657.156-RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, por unanimidade, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018 (Tema 106 – recurso repetitivo) (Info 625).

No caso em apreço, os laudos médicos juntados às fls. 16-20 dos autos comprovam que o diagnóstico da parte autora e a relação de medicamentos destinados ao tratamento das moléstias.

Entretanto, em relação ao Protocolo Clínico de Diretrizes Terapêuticas, a parte autora afirma que passou por alguns tratamentos medicamentosos padronizados no PCDT e não melhorou o quadro da enfermidade.

A comprovação da imprescindibilidade dos medicamentos, assim como a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS no tratamento da doença, não se realizou. Conforme consta a fls. 18-20, documento juntado pela parte autora, o profissional afirma que não há tratamento fornecido pelo SUS, motivo pelo qual não receitou os medicamentos disponibilizados pelo Poder Público.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VINICIUS DOS ANJOS BORBA, liberado nos autos em 27/01/2023 às 17:36 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800269-75.2020.8.12.0040 e código S7R5507E.

Em relação aos fármacos, o Parecer Técnico nº 2530/2020 do Núcleo de Apoio Técnico opiniou desfavoravelmente ao fornecimento. Consignou a existência medicamentos disponibilizados pela rede pública de saúde destinados ao tratamento das doenças que acometem a parte autora, conforme Protocolo Clínico e Diretreizes Terapêuticas (PCDT) da Dor Crônica:

> **IX - Sugerir medicamentos ou tratamentos similares ao requerido, preferencialmente existentes no Sistema Único de Saúde (SUS) obrigatoriamente registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) de comprovada e equiparada eficiência ao requisitado judicialmente, com a mesma comodidade de uso e comparação de custo orçamentário;**
>
> O Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) da Dor Crônica, Portaria SAS/MS nº 1083 de 02 de outubro de 2012, oferece os medicamentos Ácido Acetilsalicílico, Dipirona, Paracetamol, Ibuprofeno, Amitriptilina, Nortriptilina, Clomipramina, Fenitoína, Carbamazepina, Gabapentina, Ácido Valproico, Codeína, Morfina, Metadona aos pacientes cadastrados.
>
> A RENAME 2020 tem padronizado no Componente Básico da Assistência Farmacêutica (CBAF) medicamentos analgésicos (Dipirona, Paracetamol), anti-inflamatório (Ibuprofeno), antidepressivos (Amitriptilina, Nortriptilina, Clomipramina, Fluoxetina), antiepiléticos (Ácido Valproico, Fenitoína, Fenobarbital, Carbamazepina), vitaminas (Tiamina, Piridoxina, Cianocobalamina), suplemento mineral (Carbonato de Cálcio 500mg, Carbonato de Cálcio + Colecalciferol − 500mg + 200UI ou 500mg + 400UI, Fosfato de Cálcio Tribásico 600mg + Colecalciferol 400UI), vitaminas (Cianocobalamina 1000mcg injetável, Piridoxina 40mg, Tiamina 300mg).

Assim, não há como concluir pelo esgotamento do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para seu tratamento e a verificação da ineficiência dos fármacos disponíveis pelo SUS. Desse modo, não se configura a hipótese de disponibilização de tratamento individualizado, conforme Tema 106, decidido em sede de recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça.

A propósito, transcrevo:

> REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO – DESNECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO – TEMA N.º 793, DO STF – REDIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO NÃO APLICÁVEL – NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS NO RESP N.º 1.657.156/RJ – TEMA N.º 106, DO STJ – AUSÊNCIA DE PROVA DA UTILIZAÇÃO DOS FÁRMACOS DISPONIBILIZADOS NA REDE PÚBLICA SEM A OBTENÇÃO DE RESULTADO POSITIVO – RECURSO DO ESTADO E REMESSA NECESSÁRIA PROVIDOS. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. APELO DA DEFENSORIA PREJUDICADO. Conforme Tema n.º 793, do STF, a inclusão da União no polo passivo de ações que versem sobre pedido de concessão de medicamento somente é devida se o fármaco pretendido não possuir registro na ANVISA, situação que não se apresenta no caso dos autos. Nas demandas propostas após 25.04.2018 em que se pretende a concessão de medicamento não fornecido pelo SUS, deve ser observada a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, no REsp n.º 1.657.156/RJ (Tema n.º 106), que exige os seguintes requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. Inexistindo laudo médico afirmando que a paciente fez uso dos fármacos disponibilizados pelo SUS sem comprovada ineficácia, deve ser julgado improcedente o pedido de concessão de medicamento não padronizado. Diante da improcedência do pedido inaugural, resta prejudicado o recurso interposto pela Defensoria Pública e que visava apenas a condenação do Estado ao pagamento de honorários de sucumbência. TJMS. Apelação/Remessa Necessária n. 0802093-90.2019.8.12.0012, Ivinhema, 2ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Eduardo Machado Rocha, j: 16/11/2021, p: 18/11/2021.
>
> APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – REMESSA NECESSÁRIA – CONDENAÇÃO INFERIOR AO VALOR DE ALÇADA – ILEGITIMIDADE DA UNIÃO - FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTO NÃO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VINICIUS DOS ANJOS BORBA, liberado nos autos em 27/01/2023 às 17:36 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800269-75.2020.8.12.0040 e código S7R5507E.

PADRONIZADO PELO SUS – INCAPACIDADE ECONÔMICA DA PARTE AUTORA NÃO COMPROVADA – REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA E RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Seguindo a orientação firmada pelo STJ, bem como em observância aos princípios da eficiência e da celeridade na busca pela duração razoável do processo, os quais, com a vigência do novo Código de Processo Civil, tornaram-se mais acentuados, fica dispensada a remessa no presente caso. 2. O Recurso Extraordinário n° 855.178 (Tema n° 793) reafirma a possibilidade de a parte autora demandar contra todos ou alguns dos entes públicos, no que tange às demandas de saúde, o que não implica óbice a ação proposta pela parte autora contra o Estado de Mato Grosso do Sul apenas 3. Nos termos do julgado do STJ (REsp 1657156/RJ) com efeito repetitivo de observância obrigatória, para o fornecimento de medicamentos não previstos nas listas do SUS se faz necessária comprovação dos requisitos seguintes de forma cumulativa: a) laudo médico informando a imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; b) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; c) existência de registro do medicamento na ANVISA. 4. A incapacidade financeira do autor/apelado de arcar com o custos do medicamento prescrito não restou comprovada, mesmo após intimado a juntá-lo em conversão do julgamento em diligência. 5. Com isso, porque não cumprido requisito essencial, deve ser reformada a sentença para improcedência do pedido inicial. TJMS. Apelação/Remessa Necessária n. 0801457-24.2019.8.12.0013, Jardim, 4ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Sideni Soncini Pimentel, j: 16/12/2020, p: 06/01/2021.

III. Dispositivo.

Ante o exposto, **sentencio o processo com resolução de mérito**, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e **julgo improcedentes** os pedidos formulado por **Juliana Paniagua** em desfavor de **Município de Porto Murtinho e Estado de Mato Grosso do Sul.**

Revogo a decisão que concedeu a tutela provisória.

Condeno a parte autora no pagamento das despesas processuais na proporção e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% do valor da causa, à luz do art. 85, parágrafo 2º, do CPC.

Suspendo, todavia, a exigibilidade dos ônus sucumbenciais, eis que beneficiária da justiça gratuita (art. 98, § 3º, CPC).

Aforados embargos de declaração, façam-se os autos conclusos na fila correspondente.

Interposto(s) recurso(s) de apelação, intime(m)-se a(s) parte(s) adversa(s) para, querendo, oferecer contrarrazões no prazo legal, consoante artigo 1.010, § 1º, do CPC. Manejado recurso de apelação na forma adesiva, intime(m)-se a(s) parte(s) adversa(s) para, querendo, oferecer contrarrazões no prazo legal, na forma do artigo 1.010, § 2º, do CPC. Observem-se eventual prazo em dobro, nos termos dos artigos 180, 183 e 186 do CPC.

Na sequência, independentemente de juízo de admissibilidade, encaminhe-se os autos ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso Sul para apreciação do(s) recurso(s).

Transitada em julgada, promova-se o necessário ao recolhimento das custas pendentes, e arquivem-se os autos com as devidas anotações no sistema.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Porto Murtinho, 27 de janeiro de 2023.

Vinícius dos Anjos Borba
Juiz Substituto
(assinado por certificação digital)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VINICIUS DOS ANJOS BORBA, liberado nos autos em 27/01/2023 às 17:36 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800269-75.2020.8.12.0040 e código S7R5507E.